医学康复

·临床研究·

汉语成语组合关联词语在脑卒中非流畅性失语中的应用研究

李薇薇[a],何小俊[b],朱珊珊[c],胡含波[d],孙沛[e]

【摘要】 **目的**:探讨汉语成语组合关联词语康复策略在脑卒中非流畅性失语患者语言康复中的应用效果。**方法**:脑卒中非流畅性失语症患者63例,分为观察组31例和对照组32例。2组均给予神经内科常规治疗及康复,观察组在此基础上结合汉语成语组合关联词语的康复策略,比较2组患者训练前后语言功能。**结果**:训练2周后,观察组患者的听理解、复述、说、出声读、阅读等各项语言功能评分均高于训练前及对照组(均$P<0.05$),对照组除说项目的画面说明、漫画说明、阅读项目的执行文字命令的评分差异无统计学意义外,其余各项语言功能评分均高于训练前(均$P<0.05$)。**结论**:汉语成语组合关联词语的言语康复训练后,观察组听理解、复述、说、出声读、阅读各项语言功能的提高优于对照组,汉语成语组合关联词语康复训练能有效提高脑卒中非流畅性失语症患者的听理解、复述、说、出声读、阅读能力。

【关键词】 脑卒中;非流畅性失语症;言语康复;汉语成语

【中图分类号】 R49;R743.3 【DOI】 10.3870/zgkf.2022.04.001

Application of Chinese Idiom-related Speech Rehabilitation Training in Non-fluency Aphasia after Stroke

Li Weiwei, *He Xiaojun*, *Zhu Shanshan*, *et al*. *Renming Hospital of Wuhan University*, *the First Clinical College of Wuhan University*, Wuhan 430060, China

【**Abstract**】 **Objective**: To explore the application effect of Chinese idiom-associated speech rehabilitation training method in stroke non-fluency aphasia. **Methods**: A total of 62 stroke patients with non-fluency aphasia in the Department of Neurology of a third-class hospital in Wuhan were selected and divided into observation group ($n=30$) and control group ($n=32$). The control group was given routine neurology treatment and nursing; the observation group was given two weeks of Chinese idiom-related speech rehabilitation training on the basis of neurology routine treatment and nursing, and the language function of the two groups before and after the training was compared. **Results**: After speech rehabilitation training, the differences in the language function scores of listening comprehension, retelling, speaking, reading aloud, and reading were statistically significant between two groups (all $P<0.05$). **Conclusion**: After speech rehabilitation training, the language functions of retelling, speaking, reading aloud, and reading in the observation group are better than those in the control group. Chinese idiom-related speech rehabilitation training can effectively improve the language function of stroke patients with non-fluency aphasia.

【**Key words**】 stroke; non-fluentcy aphasia; speech rehabilitation; Chinese idioms

脑卒中是指由于脑血管破裂或阻塞而引起的脑损伤疾病,卒中后约有25%~33%的患者伴随失语症[1-2],导致患者听、说、读、写等语言功能受到不同程度的损害,给患者及其家庭带来严重的心理、社会及经济负担[3-4]。言语康复是指专业人员将言语训练素材(文字、音频、图片等)通过相关策略对患者进行言语训练。由于失语症患者有着不同的职业、教育背景等特点,提供多样性的言语康复训练素材,有效促进语言功能恢复是目前临床迫切关注的问题。汉语成语是我国普遍使用的书面语及口语,有着广泛的熟悉度及丰富的故事背景,可形成相关联的字、词、句子、段落等语言形式,此外,成语有着极强的韵律感及节奏[6-7],与失语症言语康复训练中的旋律语调法(MIT)的素材选择标准相一致,本研究选择汉语成语组合关联词为训练素材,将其应用于脑卒中后非流畅性失语症患者的言

基金项目:武汉市科技局课题(2013062301010820);武汉大学人民医院院内课题(HL2020YB-01)
收稿日期:2021-08-08
作者单位:武汉大学人民医院 a.老年病科,b.干部保健处,c.康复科,d.肿瘤一科,e.第一临床学院,武汉 430060
作者简介:李薇薇(1989-),女,主管护师,主要从事脑卒中后失语症康复方面的研究。
通讯作者:何小俊,13908653137@139.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

语康复，探讨其应用效果，报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年4月～2019年5月武汉市某三甲医院神经内科收治的65例脑卒中失语症患者，纳入标准：符合脑血管病学术会议制定的卒中诊断标准[10]，影像学检查（头颅CT、MRI）证实为左侧大脑脑梗死，且为首次急性脑卒中发作；经《西部失语症成套测试》（Western Aphasia Battery，WAB）诊断为失语症的患者（失语商（AQ）小于93.8）[11]；初中及以上文化程度；意识清楚能合作，听理解能力相对较好（经WAB评估[11]，非流畅性失语患者听理解能力≥4），脑卒中前智力正常，无精神病史及语言障碍；右利手，未经过言语训练治疗；疾病处于稳定期，生命体征平稳，年龄为45～70岁；知情并同意参加本次测试与试验；排除标准：认知障碍；听力障碍；构音障碍、语音错语；精神障碍；双眼矫正视力＜1.0或视野缺损；言语失用；严重或急性的内分泌、胃肠道、心、肝、肺、肾疾病或恶性肿瘤；拟妊娠、妊娠或哺乳期患者；患者或家属签署本研究知情同意书，且本研究经医院伦理委员会审核批准。按照随机数字表法将患者分为观察组和对照组，纳入的65例患者中有1名患者转院治疗，有1名患者未坚持完成康复，均退出本研究，最终纳入患者63例，观察组31例，对照组32例。见表1。

表1 2组患者一般资料比较

项目	观察组（n=31）	对照组（n=32）	t/χ^2	P
性别（例）			0.668	0.556
男	25	23		
女	6	9		
年龄（岁，$\bar{x}\pm s$）	57.87±7.52	58.16±6.93	−0.157	0.876
文化程度（例）			0.902	0.696
初中	11	15		
高中	15	13		
大学及以上	5	4		
医疗支付方式（例）			0.527	0.813
自费	3	4		
新农村合作医疗	10	8		
省市医疗保险	18	20		
脑卒中类型（例）			0.413	0.520
脑梗死	26	24		
脑出血	5	7		
失语症类型（例）			0.857	0.736
Broca失语	9	10		
经皮质运动性失语	12	9		
命名性失语	10	13		

1.2 方法

1.2.1 对照组 对照组患者在住院期间接受神经内科常规治疗，包括改善语言功能的训练、健康指导、康复指导等。常规言语训练包括指导患者进行发音辅助的练习，呼吸调节、发音肌肉运动和发音练习，此方法同观察组。

1.2.2 观察组

1.2.2.1 构建言语康复训练团队 由文学系教授、言语康复师等四人组成言语康复训练团队，分工如表2。

表2 小组成员分工

成员（数量）	分工
文学系教授（1名）	负责汉语成语的筛选以及关联词语的选取
言语康复师（1名）	负责语言功能评估，言语康复训练培训，制订言语康复训练计划
研究生（1名）	协助研究者进行研究对象的纳入及言语康复训练
研究者（1名）	研究方案的设计及执行，资料的收集及分析

1.2.2.2 言语康复训练素材的制订——汉语成语组合关联词语的选取 ①汉语成语的筛选：研究者与文学系教授从《学生实用成语词典》中选取由简易字、常见字组成的四字汉语成语，去除含有悲观意义的成语，最终纳入四字成语28个见表3。②汉语成语关联词语的选择：汉语成语关联词语的选取标准满足以下任意一条标准即可：与成语所表达的意境相关联；与汉语成语组成字相关联；成语所表达的意思或成语组成字的反面；利用汉语成语组合关联词语以形成多个互相关联的词语组，以部分成语及关联词语为例，见表4。

表3 筛选的汉语成语

安家乐业	车水马龙	津津有味	家喻户晓	如数家珍	时来运转	口口声声
议论纷纷	雄心勃勃	行色匆匆	两手空空	相貌堂堂	念念不忘	得意扬扬
喜气洋洋	吞吞吐吐	千千万万	马马虎虎	心心相印	堂堂正正	蒸蒸日上
花花世界	源源不断	息息相关	原原本本	落落大方	察言观色	爱不释手

表4 部分成语及关联词语

成语	关联词语						
车水马龙	小车	自行车	步行	堵车	马车	流水	繁华
安居乐业	家庭	工作	劳动	安定	快乐	难过	
津津有味	兴趣	浓厚	枯燥	味道	尽兴	乏味	
家喻户晓	知道	邻居	流行	比喻	户口	破晓	
如数家珍	比如	宝贝	数学	珍宝	熟悉	清楚	泛滥
时来运转	处境	时机	命运	运气	变化	改变	机会

1.2.2.3 汉语成语组合关联词语的言语康复训练 在对观察组患者进行神经内科常规治疗、基础护理、专科护理的基础上，给予汉语成语组合关联词语的言语康复训练。训练过程如下：①发音辅助练习：包括呼吸调节、发音肌肉运动和发音练习。呼吸调节是指导患者经鼻深吸气，缩唇呼气，练习鼻咽口腔闭锁功能。发音肌肉运动：进行舌肌、面肌的训练，指导患者练习鼓腮、卷舌、咀嚼等。发音练习：指导患者进行元音字母的发音练习。②康复训练：将纳入的成语及关联词语录入电脑，字体为楷体，字号72，颜色为黑色，通过幻灯片展示素材，成语及关联词语均匹配相应的图片和语音提示。训练方法如下：患者能读出完整的成语，继续指导患者读出关联词语；患者不能读出完整的成语，指导患者读出成语中的某个字，根据成语的固定搭配（四字成语中的前两个字和后两个字均是固定搭配词语），引导患者读出固定搭配中的剩余字，再继续引导患者读出关联词语；当患者对所有成语组成字提取困

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

难时，直接展示成语的关联词语，引导患者读出关联词语，再引导其读出成语；当汉语成语及关联词语均不能读出时，选择另一个成语及关联词语；当天对读出的汉语成语及关联词语进行复习，以巩固训练效果。③训练时间：患者病情稳定，生命体征平稳后进行训练，每天45min根据患者精神状态，可分次进行，训练时间为2周，一周7次。④训练地点：根据患者肢体运动情况，训练地点为病房或康复室。

1.3 评定标准 于患者言语康复开始前与训练结束后采用中国康复研究中心的《汉语标准失语症检查量表》(China Rehabilitation Research Center Aphasia Examination，CRRCAE)进行评定，其是借鉴日本标准失语症检查法(Standard Language Test of Aphasia，SLTA)编制而成[13]，用于诊断和评估脑卒中失语症患者的语言功能，评估内容包括听理解4个维度、复述3个维度、说5个维度、出声读3个维度和阅读4个维度，每个维度最高分为6分，最低分为1分，评估分数越高，言语功能越好。张庆苏等[14]研究对CRRCAE量表的信效度研究表明CRRCAE总分和各分项目的Cronbacha信度系数均>0.80，在评价患者的训练效果方面的敏感度为0.94，CRRCAE具有良好的信度和敏感度，其总分在反映失语症严重程度方面具有较好的有效性。研究过程中患者的语言功能由言语康复师进行评估，言语康复师对患者分组不知情。为避免样本沾染，观察组与对照组不安排在同一间病房。

1.4 统计学方法 数据录入Excel，采用SPSS 20.0处理分析数据，计量资料用 $\bar{x}\pm s$ 表示，对于配对计量资料的比较，若差值符合正态分布，采用配对样本 t 检验，差值不符合正态分布的采用配对样本Wilcoxon符号秩检验，对于两样本计量资料的比较，若样本符合正态分布，则采用两独立样本 t 检验，若不符合，则采用两独立样本Wilcoxon符号秩检验，构成比的比较采用卡方检验，检验水准为 $\alpha=0.05$。

2 结果

训练前，2组患者的语言功能比较，听、复述、说、出声读、阅读各项语言功能评分的差异均无统计学意义。训练2周后，观察组患者的听理解、复述、说、出声读、阅读等各项语言功能评分均高于训练前(均 $P<0.05$)，对照组除说项目的画面说明、漫画说明、阅读项目的执行文字命令的评分差异无统计学意义外，其余各项语言功能评分均高于训练前(均 $P<0.05$)；观察组各项语言功能评分均高于对照组(均 $P<0.05$)。见表5。

3 讨论

非流畅性失语症是脑卒中后严重影响生活质量的并发症之一，探讨更多形式的康复语言素材，以满足患者的训练需求，达到训练效果最大化。

3.1 汉语成语组合关联词语的言语康复训练对患者语言功能的影响 观察组患者在训练前后的CRRCAE语言功能评分上，听理解、复述、说、出声读、阅读项目的评分差异比较均有统计学意义。选择汉语成语作为训练素材，是因其具有广泛的大众熟悉度和生动

表5 2组训练前后各项语言功能评分比较 分，$\bar{x}\pm s$

项目(维度)		训练前				训练后				观察组训练前后		对照组训练前后	
		观察组(n=31)	对照组(n=32)	t/Z	P	观察组(n=31)	对照组(n=32)	t/Z	P	t/Z	P	t/Z	P
听理解	名词	31.45±2.93	29.94±3.60	1.83*	0.07	20.29±3.65	10.44±4.33	9.74*	0.00	−20.48*	0.00	−4.96#	0.00
	动词	29.39±5.31	29.00±5.30	−0.38#	0.70	23.39±5.06	7.16±2.26	16.34*	0.00	−26.53*	0.00	−11.52*	0.00
	句子	19.55±5.01	19.00±4.91	0.44*	0.66	24.48±4.84	11.44±2.05	13.86*	0.00	−4.89#	0.00	−4.68#	0.00
	执行口头命令	14.61±4.19	14.47±3.52	−0.51#	0.61	25.19±3.47	12.41±1.56	18.77*	0.00	−35.62*	0.00	−4.97#	0.00
复述	名词	28.36±4.31	28.16±4.36	−0.59#	0.56	23.65±2.56	1.31±2.16	22.35*	0.00	−4.91#	0.00	−4.97#	0.00
	动词	30.01±5.37	29.47±5.14	−0.61#	0.54	23.26±3.53	9.47±1.05	−6.88#	0.00	−4.95#	0.00	−5.06#	0.00
	句子	15.39±4.01	15.22±3.63	−0.39#	0.70	27.00±3.29	11.22±1.86	23.35*	0.00	−4.88#	0.00	−4.98#	0.00
说	命名	22.16±5.11	21.63±4.55	−0.70#	0.49	23.65±1.74	10.06±1.19	−6.86#	0.00	−4.91#	0.00	−5.01#	0.00
	动作说明	22.48±6.06	21.50±5.63	−1.22#	0.22	27.32±3.97	10.91±1.53	21.53*	0.00	−4.89#	0.00	−4.99#	0.00
	画面说明	11.68±3.62	11.81±3.34	−0.15*	0.88	24.52±2.10	11.13±1.31	30.28*	0.00	−4.92#	0.00	−1.00#	0.32
	漫画说明	1.58±0.67	1.53±0.72	−0.24#	0.81	3.06±0.85	1.91±0.93	−4.44#	0.00	−4.70#	0.00	−0.58#	0.56
	水果列举	0.97±0.98	1.03±0.97	−0.31#	0.76	3.23±1.02	1.50±0.84	−5.43#	0.00	−4.93#	0.00	−4.26#	0.00
出声读	名词	27.90±4.21	26.69±3.76	1.21*	0.23	22.97±2.55	10.50±1.37	−6.87#	0.00	−5.05#	0.00	−5.01#	0.00
	动词	27.87±3.97	27.47±4.20	−0.40#	0.69	22.55±2.25	10.25±1.37	−6.89#	0.00	−4.98#	0.00	−5.05#	0.00
	句子	14.55±4.67	14.03±3.91	−0.25#	0.80	22.97±2.17	7.16±3.34	−6.86#	0.00	−4.92#	0.00	−4.98#	0.00
阅读	名词	30.45±2.67	29.60±2.93	1.21*	0.23	22.19±3.82	8.53±2.72	−6.62#	0.00	−5.01#	0.00	−5.03#	0.00
	动词	30.16±2.46	29.44±2.73	1.10*	0.28	22.19±4.77	8.59±1.36	15.28*	0.00	−4.95#	0.00	−5.01#	0.00
	句子	26.16±2.19	27.34±5.97	−0.44#	0.66	25.00±5.76	8.44±2.08	15.08*	0.00	−4.94#	0.00	−5.03#	0.00
	执行文字命令	15.97±3.17	14.91±2.87	1.40*	0.17	21.74±2.83	5.22±1.41	29.21*	0.00	−4.92#	0.00	−1.73#	0.08

*：表示两独立样本 t 检验；#：两独立样本Wilcoxon符号秩检验

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的故事背景;此外,在语言构成上,具有显著的韵律感、节奏感,与旋律语调疗法的语言素材标准相符合。汉语成语的韵律感体现在由声调形成的平仄韵律;其次,汉语成语是固定搭配,具有节奏感,这种节奏使得发音速度减慢,增加吐字的清晰度,这与研究发现词语或句子的韵律会减慢发音的速度[15],可以减少对左侧大脑的依赖。其次成语两个字一个节拍的节奏感帮助患者为读下一个字所需的发音器官的启动和语音的提取做准备,缓解心里紧张[16]。这与 Stahl[17] 研究结果表明节奏式表达能促进语音的提取和表达相一致。汉语成语本身具有的背景故事增加了训练的趣味性,基于李文兵等[18]的研究发现使用患者熟悉的文本材料进行训练,能提高患者对文本的朗读,刺激患者的理解及联想能力。李文兵等[18]研究表明非流畅性失语症患者的语音编码可能保留,但对语音编码的提取能力受损,致口语输出障碍。本研究选择的汉语成语及关联词语均为辨识度高的词语,这与 Breier 等[19]研究结果表明失语症患者口语输出能力的提高是由于对记忆部位相关文字语音编码再提取的能力重新获取,而不是对语言的再学习相似。汉语成语具有特定的情境,能激发患者的想像和联想,这与 Breitenstein[20] 的研究结果发现基于情境的文本或对话能提高患者的语言功能和理解能力相一致,此外,熟悉的情境文本能降低患者对文本信息的理解难度,能提高患者对训练的积极性和信心。熟悉的文本或词汇能给患者形成较强的视觉刺激,可能激发患者左顶叶残存的神经元反应,使得左顶叶神经元数量增加,促进侧支神经网络的再生,从而改善患者的理解能力[21]。

3.2 *常规疗法对对照组患者的影响* 对照组在训练前后的 CRRCAE 语言功能评分上,画面说明、漫画说明及执行文字命令维度的评分比较,差异均无统计学意义,其余项目各维度评分比较,差异均具有统计学意义。对照组在听理解、复述、说、出声读、阅读等项目评分上的提高可能是由于自然恢复的结果,但恢复程度极为有限[22],脑卒中后前 12 个月对患者实施言语康复训练会加速自然恢复,一年以后,自然恢复完全停止,但约 50%的患者仍然存在长期(一年以上)的语言功能缺损[24-25]。对照组在画画说明、漫画说明和执行文字命令维度的训练前后 CRRCAE 语言功能评分差异无统计学意义,这可能是由于这三者不仅需要患者进行口语输出,更重要的是需要患者进行语言组织、逻辑思考和记忆等方面的综合能力的输出,而这些能力的提高需要较长时间的针对性训练,这也与以往研究结果表明失语症患者的听理解、口语表达及阅读能力恢复的最好,时间最短相一致[22-23].

3.3 *展望* 脑卒中后失语症的言语康复训练一直受到临床医护人员的高度重视,语言功能的缺损严重影响患者的社会融入,为患者提供成熟的、有效地言语康复训练,迫在眉睫,但仍面临诸多问题。语言康复专业人才短缺,资源分布不均,医院社区的连接等问题仍处于探索阶段,有待学者们进一步研究。

【参考文献】

[1] Azar M, Askar G, Ali D, et al. Comparing the production of complex sentences in Persian patients with post-stroke aphasia and non-damaged people with normal speaking:[J]. Iranian Journal of Neurology, 2016, 15(1):28-33.

[2] Worrall L, Foster A. Does intensity matter in aphasia rehabilitation[J]. Lancet, 2017,389(10078):1494-1495.

[3] Ali M, Lyden P, Brady M. Aphasia and dysarthria in acute stroke: recovery and functional outcome[J]. International Journal of Stroke, 2015, 10(3):400-406.

[4] Palmer R, Cooper C, Enderby P, et al. Clinical and cost effectiveness of computer treatment for aphasia post stroke (Big CACTUS): study protocol for a randomised controlled trial[J]. Trials, 2015, 16(1):18.

[5] 朱晓菊,何小俊.数字型汉语成语耦合音乐治疗对脑卒中非流畅性失语症患者语言功能的影响[J].中国康复,2021,36(4):235-238.

[6] 杨帅.从韵律角度探析四字格成语的结构变异[J].湖北师范学院学报(哲学社会科学版),2014,34(2):51-54.

[7] 徐硕.四字成语韵律分析[J].散文百家,2019,(11):43.

[8] 刘子楗.汉语四字格的构式功能研究[D].黑龙江大学,2017.

[9] 刘振前,庄会彬.韵律语法视域下的汉语四字格成语研究[J].对外汉语研究,2015(1):56-67.

[10] 脑卒中病情监测中国多学科专家共识[J].中华医学杂志,2021,101(5):317-326.

[11] John A A, Javali M, Mahale R, et al. Clinical impression and Western Aphasia Battery classification of aphasia in acute ischemic stroke: Is there a discrepancy? [J]. J Neurosci Rural Pract, 2017, 8(1):74-78.

[12] 薛宝柱.急性脑卒中患者精神状况及影响因素分析[J].中国实用神经疾病杂志,2016,19(8):77-78.

[13] 李胜利.语言治疗学[M].北京:人民卫生出版社,2008,70-79.

[14] 张庆苏,纪树荣,李胜利,等.中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表的信度与效度分析[C].首届中国国际言语治疗会议.北京.2007.

[15] Grechuta K, Ballester B R, RE Munné, et al. Multisensory cueing facilitates naming in aphasia. J Neuroeng Rehabil. 2020,9;17(1):122.

[16] Aravantinou-Fatorou K, Fotakopoulos G. Efficacy of exercise rehabilitation program accompanied by experiential music for recovery of aphasia in single cerebrovascular accidents: a randomized controlled trial. Ir J Med Sci. 2021,190(2):771-778.

[17] Uslu A S, Gerber S M, Schmidt N, et al. Investigating a new tablet-based telerehabilitation app in patients with aphasia: a randomised, controlled, evaluator-blinded, multicentre trial proto-

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

col.[J].BMJ Open. 2020 ,10(11):e037702.
[18] 李文兵,张通,宋鲁平.非流畅性失语患者口语产出障碍机制的研究[J].中国康复理论与实践,2012,18(12):7-9.
[19] Tarrant M, Carter M, Dean SG, et al. Calitri R. Singing for people with aphasia (SPA): results of a pilot feasibility randomised controlled trial of a group singing intervention investigating acceptability and feasibility. [J]. BMJ Open. 2021 ,11(1): e040544.
[20] Breitenstein C, Grewe T, Fl el A, Ziegler W, et al. Intensive speech and language therapy in patients with chronic aphasia after stroke: a randomised, open-label, blinded-endpoint, controlled trial in a health-care setting. Lancet. 2017,389(10078):1528-1538.
[21] Stefaniak JD, Halai AD, Lambon Ralph MA. The neural and neurocomputational bases of recovery from post-stroke aphasia. [J]. Nat Rev Neurol. 2020,16(1):43-55.
[22] 邢一兰,吴宏,胡欢.失匹配负波评估卒中后失语自然恢复的价值研究[J].中国全科医学,2018,21(5):535-540.
[23] 葛政卿,刘杰,赵莹楚.ICF理念下失语症命名障碍的精准康复[J].中国康复,2020,35(2):65-67.
[24] Ren CZ, Lv XY, Zhang XJ, et al. Acupuncture technique of Jingou Diaoyucombined with speech rehabilitation training for post-stroke motor aphasia. [J]. Zhongguo Zhen Jiu. 2020,40(10):1037-1041.
[25] Tmh H, Leff A P, Prejawa S, et al. Right hemisphere structural adaptation and changing language skills years after left hemisphere stroke[J]. Brain A Journal of Neurology, 2017, 140(6): 1718-1728.

·外刊拾粹·

加巴喷丁类药物引起的水肿

加巴喷丁类药物被批准用于治疗癫痫和一些神经性疼痛,并被广泛用于下背痛(LBP)的超适应症治疗。由于高达16%的使用者出现了外周性水肿,本研究回顾了接受加巴喷丁类药物治疗的新发LBP患者中利尿剂的使用率。这项加拿大的回顾性队列研究从安大略省公共资助的全民健康保险计划中检索了数据,并从这些数据中确定了66岁及以上新诊断为LBP的居民。研究的主要结局变量是开具加巴喷丁类药物后90天内配予的利尿剂。次要分析是在治疗开始后180天内停用加巴喷丁类药物。LBP患者的最终队列包括7867名新的加巴喷丁类药物使用者和252477名非使用者。在90天时,加巴喷丁组2%的受试者和对照组1.3%的受试者使用了利尿剂(调整后的风险比为1.44)。到180天时,加巴喷丁组使用利尿剂累积发生率为3.1%,对照组为2.4%。总体而言,47%的队列在数据导出日期的30天内停止了加巴喷丁类药物的治疗。结论:这项针对老年下背痛患者的研究发现,使用加巴喷丁类药物治疗导致利尿剂的使用率增加44%,该结论进一步为此类药物可能导致外周性水肿提供了证据。

(余子 译 陆蓉蓉、吴毅 校)

Read S, et al. Evidence of a Gabapentinoid and Diuretic Prescribing Cascade among Older Adults with Lower Back Pain. J Am Geriatr Soc. 2021, 69(10): 2842-2850.

中文翻译 由 WHO康复培训与研究合作中心(武汉)组织
本期由复旦大学附属华山医院 吴毅教授主译编

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net